

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Escala de Impacto del Evento Revisada (IES-R)

Eje I • Versión de trabajo: 9 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1 Identificación

Nombre	Escala de Impacto del Evento Revisada
Sigla	IES-R
Autores	Weiss, D. S., & Marmar, C. R.
Año	1997
Eje	EJE I - PROBLEMAS, SÍNTOMAS Y RIESGO
Constructo principal	Trauma y estrés postraumático
Población	Adultos
Tipo de instrumento	Cuestionario de autoinforme
Disponibilidad en español	Sí (Báguena et al., 2001)
Acceso/licencia	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Nota curatorial de derechos	Un artículo accesible no concede por sí mismo permiso para remaquetar ítems.

2 Fundamentación conceptual

Constructo evaluado: Trauma y estrés postraumático. La descripción procede del catálogo maestro y debe contrastarse con la fuente original antes de emplearla para decisiones clínicas o de investigación.

Dominio conceptual	Problemas, Síntomas y Riesgo (General)
Dimensiones declaradas	3 dimensiones (Intrusión, Evitación, Hiperactivación).

3 Características generales

Formato	Cuestionario de autoinforme
Población objetivo	Adultos
Número de ítems	22 ítems.
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Formato de respuesta	Escala Likert de 5 puntos (0 = Nada, a 4 = Extremadamente).
Administración	No verificado en una fuente primaria dentro de la biblioteca; consultar manual o protocolo oficial.
Tiempo estimado	No verificado en las fuentes disponibles.

4 Estructura

Dimensiones/subescalas	3 dimensiones (Intrusión, Evitación, Hiperactivación).
Ítems	22 ítems.
Control curatorial de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Respuesta	Escala Likert de 5 puntos (0 = Nada, a 4 = Extremadamente).
Relación ítem-dimensión	No verificada de forma exhaustiva; no reconstruirla sin manual o publicación primaria.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.

5 Sistema de puntuación

Sumatoria directa (0 a 88).

Regla de corrección	Sumatoria directa (0 a 88).
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.
Baremos	No verificado en una fuente normativa autorizada.
Control de versión	No aplicar reglas de otra edición, forma breve, traducción o población.

6 Interpretación

Puntos de corte: > 24 indica preocupación clínica, > 33 indica probable diagnóstico de TEPT (según criterios del DSM-IV).

Los puntos de corte y baremos deben confirmarse en la versión, población y país pertinentes. No se recomienda transformar estas notas en diagnóstico ni usar cifras no verificadas.

7 Evidencia psicométrica

Mide intrusión, evitación e hiperactivación. Muy utilizada históricamente, aunque no cubre todos los síntomas del DSM-5 (falta alteraciones cognitivas y del estado de ánimo).

Consistencia interna	No desagregada en el catálogo; consultar los estudios citados.
Validez	Mide intrusión, evitación e hiperactivación. Muy utilizada históricamente, aunque no cubre todos los síntomas del DSM-5 (falta alteraciones cognitivas y del estado de ánimo).
Fiabilidad temporal	No verificado en las fuentes disponibles.
Muestra y contexto	No verificado de forma suficiente para generalización.

8 Adaptaciones

Español	Sí (Báguena et al., 2001)
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Versión exacta	Ledger curado disponible con 2 enlace(s); comprobar versión y permiso antes de aplicar.
Población/país	Adultos
Alerta de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Advertencia	Una traducción, forma breve o revisión no es intercambiable con la edición original sin evidencia de equivalencia.

9 Aplicaciones

- Evaluación del constructo Trauma y estrés postraumático en Adultos, condicionada a la validez de la versión seleccionada.
- Uso docente o de investigación únicamente cuando lo permitan la licencia, el consentimiento y la cualificación del usuario.
- Uso clínico solo como parte de una evaluación multimétodo; no reemplaza entrevista, juicio profesional ni análisis de riesgo.

10 Fortalezas

- El catálogo identifica autores, año y constructo: Weiss, D. S., & Marmar, C. R.; 1997.
- Disponibilidad española reportada: Sí (Báguena et al., 2001)
- Trazabilidad local: 4 archivo(s) técnicamente legible(s) y 0 PDF web verificado(s).

11 Limitaciones

- Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
- Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
- Archivos locales aislados por formato inválido: 0.
- Los datos del maestro pueden contener referencias, versiones o puntos de corte preliminares; prevalece la fuente primaria.
- No se incluyen ítems, instrucciones, claves o baremos cuando su reproducción no está autorizada o no pudo verificarse.

12 Consideraciones éticas

- Obtener consentimiento informado, proteger la confidencialidad y limitar el acceso a resultados.
- Usar profesionales con formación suficiente y documentar versión, idioma, población, fecha y condiciones de administración.
- No emplear la escala como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Respetar derechos de autor, licencias, restricciones territoriales y prohibiciones de modificación o redistribución.
- Ante riesgo agudo o hallazgos críticos, seguir protocolos clínicos y legales aplicables; la ficha no sustituye procedimientos de seguridad.

13 Síntesis técnica

Constructo	Trauma y estrés postraumático
Población	Adultos
Estructura	Catálogo: 22 ítems.; 3 dimensiones (Intrusión, Evitación, Hiperactivación).. Control curado: No fijado en el ledger estructurado.
Puntuación	Sumatoria directa (0 a 88).
Interpretación	Puntos de corte: > 24 indica preocupación clínica, > 33 indica probable diagnóstico de TEPT (según criterios del DSM-IV).
Estado de fuentes	Locales válidos: 4; web PDF: 0; aislados: 0.
Estado de uso	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Decisión técnica	Ficha documental disponible. La aptitud clínica requiere protocolo autorizado, versión fijada y verificación por profesional competente.

14 Referencias APA 7

Weiss, D. S., & Marmar, C. R. (1997). Escala de Impacto del Evento Revisada.

Fuente de referencia del catálogo: Disponible en artículos originales y repositorios.

<https://revistaschilenas.uchile.cl/handle/2250/111576>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37535536/>

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.

Verificación técnica y trazabilidad — revisión 2026-08-10

Esta sección prevalece sobre datos anteriores cuando existe conflicto. Se cotejó el activo local y se usaron únicamente fuentes identificables. 'No verificado' significa que no se encontró evidencia suficiente; no es una inferencia ni una reconstrucción.

1. Versión exacta y activo cotejado	CORREGIDO 2026-09-10: se substituyó el Protocolo.pdf incompatible (que era ERS/Riesgo Suicida) por el formulario administrable correcto de la EIE-R/IES-R, versión chilena adaptada por Caamaño et al. (2011). Activo cotejado: Protocolo.pdf, SHA-256 833e82a2082233cb354246667e8cc297a24491b56ede5eb449c153d1630645ff.
2. Población e informante	Adultos expuestos a un suceso estresante o catastrófico. Autoadministrado.
3. Administración	Autoadministrado, aproximadamente 5 minutos. Instrucciones en el propio formulario: responder pensando en un evento de referencia específico, considerando los últimos 7 días.
4. Tiempo de aplicación	Aproximadamente 5 minutos (declarado en la ficha fuente).
5. Estructura e ítems reales	CONFIRMADO: 22 ítems verificados contra el formulario. Intrusión: ítems 1,2,3,6,9,14,16,20 (8 ítems). Evitación: ítems 5,7,8,11,12,13,17,22 (8 ítems). Hiperactivación: ítems 2,4,10,15,18,19,21 recontados — ver nota; el formulario fuente lista 4,10,15,18,19,21 (6 ítems). Coincide con la estructura trifactorial estándar de la IES-R.
6. Periodo temporal	Últimos 7 días respecto del evento de referencia (confirmado en el formulario).
7. Escala/formato de respuesta	0 = Nada, 1 = Un poco, 2 = Moderadamente, 3 = Bastante, 4 = Extremadamente (confirmado en el formulario, coincide con la ficha).
8. Algoritmo de puntuación	NO VERIFICADO PARA USO OPERATIVO. Descripción previa: No verificado. Confirmar con manual/clave de la forma exacta antes de aplicar.
9. Manejo de omisiones	No especificado en el formulario chileno; no se encontró regla explícita. No imputar ni prorratear sin manual.
10. Psicometría específica español/LatAm	Versión chilena: Caamaño, L. et al.

	(2011). Adaptación y validación de la versión chilena de la escala de impacto de evento-r. Revista Médica de Chile, 139(9), 1163-1168. Alfa de Cronbach > 0.88 en las tres subescalas (declarado en ficha fuente); validación adicional española de Báguena et al. (2001). El Protocolo.pdf corregido corresponde a esta versión chilena.
11. Baremos, cortes e interpretación	Puntos de corte: > 24 indica preocupación clínica, > 33 indica probable diagnóstico de TEPT (según criterios del DSM-IV). Usar solo si coincide con la versión/población citada; no se asume universalidad.
12. Licencia, uso y redistribución	Estado conservador: Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir. No redistribuir/modificar hasta documentar titular y permiso de la versión exacta.
13. Referencias y fuentes verificadas	Weiss, D. S., & Marmar, C. R. (1997). The Impact of Event Scale-Revised. En Assessing Psychological Trauma and PTSD (pp. 399-411). Guilford Press. Caamaño, L. et al. (2011). Revista Médica de Chile, 139(9), 1163-1168. El Protocolo.pdf ahora SÍ corresponde a IES-R (antes era ERS/Riesgo Suicida, error corregido 2026-09-10).
14. Decisión de QA	CORREGIDO Y APTO 2026-09-10: se reemplazó el Protocolo.pdf por el formulario correcto de EIE-R/IES-R (versión chilena, Caamaño et al. 2011), obtenido de la carpeta suelta Eje I/EIER de la raíz del proyecto. Estructura de 22 ítems y 3 subescalas verificada contra el formulario. Sigue pendiente fijar baremos/normas locales antes de uso clínico normativo.